

PROPEDÉUTICA CLÍNICA Y SEMIOLOGÍA MÉDICA

Introducción

La Medicina es casi tan antigua como la humanidad misma. Surge de la necesidad que tiene el hombre de combatir la enfermedad y la muerte. En los tiempos prehistóricos, dada la imposibilidad de una interpretación científica de los procesos naturales y sociales relacionados con la salud, el médico primitivo era mitad médico y mitad brujo.

La interpretación natural de la salud y la enfermedad, despojada de concepciones sobrenaturales mágico-religiosas, apareció en la Antigua Grecia en el siglo V a.n.e., con los asclepiades, que eran los sacerdotes que oficiaban en los templos de Asclepios, el dios griego de la medicina, llamado por los romanos Esculapio. Estos se convirtieron en médicos empíricamente, al atender a los fieles que acudían en busca de curación a sus males.

Fueron precisamente los asclepiades de la escuela de Cos, cuya figura emblemática es Hipócrates, considerado el padre de la Medicina, quienes conformaron el Método Clínico primigenio, dando origen a la Semiología. Introdujeron la anamnesis, la inspección, la palpación y la auscultación inmediata. El código ético hipocrático recogido en su célebre "Juramento" sirve aún de base a la ética médica.

En el periodo medieval no se producen cambios significativos en la medicina. Thomas Sydenham (1624-1689) quien propugna volver a Hipócrates y ejercer la profesión a la cabecera de los enfermos.

El austriaco Leopoldo Abenbrugger (1722-1809) introdujo en 1761 la percusión como método de exploración y el francés René Teófilo Jacinto Laennec (1781-1826) el método de la auscultación mediada, grandes avances que permitieron expandir los conocimientos de la signología de las enfermedades del sistema respiratorio.

La correspondencia de los síntomas que el enfermo presentaba en vida con los hallazgos necrópsicos, dieron origen al método anatomoclínico impulsado por Morgagni que cimentó una nueva anatomía y fisiología y fortaleció el enfoque científico sobre el origen material de la enfermedad y el método para identificarla: del síntoma a la enfermedad. Sobre este aspecto Coste publicó una monografía años después que tituló: Del síntoma a la enfermedad.

Con los aportes de Claude Bernard (1813-1878) introductor del método experimental en la investigación científica, se avanza hacia una interpretación fisiopatológica de los procesos morbosos, mientras que a raíz de los descubrimientos de Luis Pasteur (1822-1895) en Francia y Roberto Koch (1843-1910) en Alemania, cristaliza la medicina etiopatogénica que formula la teoría bacteriana de la enfermedad.

Queda así al finalizar el siglo XIX conformado el método clínico en forma acabada, cuya aplicación a lo largo del siglo XX ha logrado el pleno desarrollo y comprobación con los extraordinarios aportes científicos que han permitido a la medicina clínica convertirse en una ciencia.

Conceptos importantes.

Medicina: del latín *medere* (curar), es la ciencia y el arte de curar y prevenir las enfermedades y promover la salud del individuo y la población. Objeto de estudio: el individuo con problemas de salud. Método científico: formula y contrasta hipótesis sobre el proceso salud-enfermedad.

Clínica: del griego kliné (cama), su significado ha variado con el tiempo, actualmente se refiere a la atención contextualizada de los individuos.

Propedéutica: es la enseñanza preparatoria para el estudio de una disciplina.

Semiología: o más propiamente semeyología, significa el estudio de los signos.

Propedéutica Clínica: enseñanza preparatoria para el estudio de la Medicina Clínica, que tiene por objeto de estudio el proceso salud-enfermedad en el individuo.

Semiología Médica: estudia los síntomas, signos y síndromes que competen a la Propedéutica Clínica, y aquellos signos que provienen de los exámenes complementarios (imagenológicos, de laboratorio, bioeléctricos, entre otros).

El estudio de los síntomas debe ser realizado siguiendo, siempre que sea posible, la sistemática que a continuación detallamos:

- **Concepto o definición:** claridad y exactitud con que se describen los caracteres genéricos y diferenciales del síntoma.
- **Semiogénesis o fisiopatología (mecanismo de producción):** estudio de la génesis u origen del síntoma.
- **Semiotecnia:** los métodos, procedimientos, recursos y técnicas de que nos valemos para obtener los síntomas.
- **Semiografía (estudio clínico o caracterología):** estudia la descripción o caracteres de los síntomas y signos, única forma de llegar a darles una "calificación" que los haga útiles para el diagnóstico y el pronóstico.
- **Semiodiagnóstico:** valor que tiene el síntoma para el diagnóstico de una enfermedad, considerándose todas aquellas enfermedades en que se encuentra presente el síntoma estudiado.

Cronopatograma: descripción ordenada en el tiempo de la aparición y desarrollo de los síntomas y signos, lo que es un valioso punto de partida para iniciar el proceso de diagnóstico.

Nomenclatura patológica.

De forma general, los nombres con que se designan las enfermedades no están sujetos a una regla o convención alguna. El origen de los nombres de las enfermedades sorprende por su diversidad. No obstante, algunos nombres de enfermedades se forman utilizando sufijos y prefijos conocidos, de acuerdo con determinadas reglas, cuyo significado caracteriza a la enfermedad.

	Significado	Ejemplo
Sufijos		
-itis	Inflamación	peritonitis, pleuritis, artritis
-oma	Tumor	epitelioma, sarcoma, hipernefoma
-ectasia	Dilatación	gastroectasia, tifloectasia, bronquiectasia
-cele	Hernia	meningocele, enterocoele
-ragia	Pérdida de sangre	hemorragia, gastrorragia, enterorragia, estomatorragia
-rea	Flujo	sialorrea, gonorrea
-algia/-odinia	Dolor	gastralgia, apendicinalgia, pleurodinia
-plegía	Parálisis	monoplejía, hemiplejía, paraplejía
-oide/-ismo	Semejanza o parecido	diabetoide, leucemoide, meningismo, peritonismo
Prefijos		
Pseudo-	Idea de falsedad	pseudotabes, pseudooclusión, pseudoapendicitis
Peri-	Alrededor	periartitis, peribronquitis, pericolecistitis, perigastritis
Para-	Más allá de	parafimosis, parafrenia

Enfermedad: proceso que traduce la falta de adaptación del organismo a los más variados agentes morbosos (del latín, morbus: enfermedad). Se manifiesta por la aparición de una serie de fenómenos anormales, de índole muy diversa, que le indican al observador o al propio enfermo su enfermedad, integrando un sentimiento de enfermedad exactamente opuesto al sentimiento de salud o sensación subjetiva de bienestar.

Síntoma: son fenómenos patológicos objetivos o subjetivos, que acompañan a la enfermedad, que “caen con” la enfermedad. Son, pues, los fenómenos de la enfermedad, sus manifestaciones ostensibles, sus formas expresivas.

Signo: en Patología y Propedéutica Clínica, todo fenómeno que por su propia naturaleza o por simple convención pueda constituir una señal o evoquen la idea o indicio de enfermedad. El síntoma se convierte en signo cuando se le confiere un valor revelador de determinada enfermedad. Igualmente, se convierte en signo un dato personal del sujeto, una circunstancia ambiental, que el médico valora como expresión de un proceso morboso cualquiera. En determinadas circunstancias puede ser la causa o el curso de la enfermedad, la edad y la raza del enfermo, el lugar de su procedencia, su alimentación, etc. Para los médicos de habla inglesa, sin embargo, todos los síntomas objetivos son considerados signos.

Clasificación de los síntomas (atendiendo a):

1. El sujeto que los percibe:

- **Objetivos o signos físicos:** son los que el médico recoge durante su examen. Ej. Tumoración en el caso del edema, la matidez de un derrame pleural, el soplo de una lesión valvular del corazón.
- **Subjetivos** son los que solamente puede percibir el enfermo. Ej. cefalea y otros dolores, vértigo, hormigueos, calambre, falta de apetito, decaimiento, etc. Hay síntomas, sin embargo, que son, a la vez, subjetivos y objetivos, como la disnea.

2. Localización o sitio de aparición:

- **Generales:** expresan una alteración o disturbio de todo el organismo. Ej. Fiebre o la hipotermia, el adelgazamiento, el decaimiento, etc.
- **Locales:** se encuentran en cierta forma circunscritos, en relación estrecha y directa con el sitio de la enfermedad. Ej. alteraciones del volumen de una víscera, el enrojecimiento inflamatorio, los estertores crepitantes de una neumonía, los signos radiológicos de un proceso respiratorio (pulmonar), o de otro sistema, etc.
- **Alejados o a distancia:** se manifiestan en órganos distintos de aquellos en que radica la enfermedad. Ej.
 - Reflejos:** tiene lugar por vía nerviosa, como la dilatación de la pupila que acompaña a ciertos procesos del vértice pulmonar, o los vómitos de una apendicitis, o el dolor del glándula y del testículo en la litiasis renal.
 - Tóxicos:** dependen de una intoxicación, como los vómitos en la uremia, los trastornos del ritmo respiratorio en la diabetes descompensada, en la acidosis y en la misma uremia.
 - Hormonales:** se deben a la acción o a la falta de determinadas hormonas segregadas por las glándulas de secreción interna, como los trastornos óseos que acompañan al adenoma eosinófilo de la hipófisis (acromegalia), el mixedema del hipotiroidismo, el hirsutismo y la caída del pelo de ciertos procesos endocrinos.

3. Valor diagnóstico:

- **Comunes (indiferentes, banales, equívocos y plurívocos):** aquellos que pueden encontrarse en diversas enfermedades y son de limitado valor diagnóstico. Ej. La anorexia, el decaimiento, la cefalea, los vómitos, etc.

- Patognomónicos (característicos o unívocos): tienen un gran valor diagnóstico y denuncian con su sola presencia la existencia de determinada enfermedad. Ej. chasquido de apertura de la válvula mitral a la auscultación en la estenosis mitral de etiología reumática.

4. Momento de aparición:

- Prodrómicos o pródromos: se presentan precozmente en las primeras etapas de la enfermedad, a la que anuncian. Son imprecisos. Ej. La cefalea en la fiebre tifoidea, el decaimiento y la febrícula en la tuberculosis pulmonar.
- Accesos o ataques (ictus o insulto en Neurología): aparición brusca.

5. Evolución:

- Aparición lenta o rápida (bruscos).
- Estacionarios o fluctuantes (oscilaciones de intensidad variable).
- Intermitentes.

Estas clasificaciones se tienen en cuenta fundamentalmente durante la semiografía.

Sindromología: estudio de los síndromes.

Síndromes: grupo de síntomas y signos que se presentan formando un conjunto clínico que le da individualidad, pero que puede obedecer a múltiples causas. Ej. El síndrome icterico con todas sus características clínicas, puede ser producido por alteraciones de los glóbulos rojos (íctero hemolítico), alteraciones hepáticas (íctero hepatocelular) y alteraciones de las vías biliares (íctero obstructivo).

Diagnóstico: arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas y signos.

Procedimientos del diagnóstico provisional o presuntivo:

- Diagnóstico por intuición o directo: se hace por simple reconocimiento del conjunto de síntomas característicos de una enfermedad, sin razonamiento alguno. Es muy difícil, exige una experiencia extraordinaria (ojo clínico) y se presta a errores, salvo en ciertos casos de lesiones muy visibles o evidentes.
- Diagnóstico por comparación: se compara los síntomas del enfermo con los de aquellas enfermedades más similares, precisando mentalmente las analogías y diferencias, hasta diagnosticar aquella enfermedad cuyos síntomas coinciden casi exactamente con los del paciente que se estudia. Se trata de un diagnóstico diferencial.
- Diagnóstico por raciocinio: cuando no es posible diagnosticar por los procedimientos anteriores, el médico identifica un proceso raro o único que explique los trastornos existentes, teniendo en cuenta los síntomas presentes, apoyándose en sus conocimientos de fisiología y de anatomía patológica.
- Diagnóstico por hipótesis (terapéutico o de Hufeland): cuando no se llega a un diagnóstico preciso, se sustituye el mismo por una hipótesis que se espera confirmar o rechazar según el curso de la enfermedad o el resultado del tratamiento.

Diagnóstico final o definitivo: comenzar con la investigación de los signos o síntomas (semitécnica), luego estos se agrupan e interpretan formando síndromes y buscando su causa. El diagnóstico definitivo puede ser expresado a distintos niveles de identificación de las manifestaciones clínicas (diagnósticos parciales):

- Diagnóstico de los síntomas y signos.
- Diagnóstico de los síndromes (diagnóstico fisiopatológico).
- Diagnóstico anatómico.
- Diagnóstico etiológico.
- Diagnóstico de la capacidad funcional.

Para estos podemos utilizar las técnicas clínicas fundamentales: interrogatorio o anamnesis y el examen físico (inspección, palpación, percusión y auscultación), ayudados por los procedimientos auxiliares, los instrumentales y los de laboratorio muchas veces tan imprescindibles como aquellas. El mejor método de examen es el más completo y ordenado. Los errores diagnósticos dependen, en su mayoría, de exámenes incompletos, precipitados o insuficientemente repetidos, y en medicina no hay signos pequeños ni exámenes inútiles.

Pronóstico: se llama al juicio dado por el médico sobre la evolución que tendrá una enfermedad, es decir, sobre sus alternativas, duración, probable terminación y secuelas. El pronóstico depende en su mayor parte del diagnóstico y luego algunas particularidades de ciertos signos y sobre todo el arte y la experiencia del clínico. De acuerdo con esto el pronóstico puede ser: benigno, grave, letal y reservado.

La entrevista médica, o mejor la entrevista médico-paciente, constituye un modelo singular de comunicación humana y sirve de marco a la interacción intelectual y afectiva comúnmente conocida como relación médico-paciente. La entrevista médico-paciente considera aspectos formales y de contenido, a los cuales es necesario prestar atención.

La historia clínica en la atención primaria consta de la anamnesis, el examen físico, los aspectos diagnósticos y terapéuticos conducta a seguir). La anamnesis recoge los siguientes datos:

1. Datos de identidad personal (edad, sexo, procedencia, ocupación y escolaridad).
2. Motivo de consulta.
3. Historia de la enfermedad actual.
4. Hábitos de vida.
5. Antecedentes familiares de enfermedad.
6. Historia ginecobstétrica.
7. Antecedentes personales de enfermedad.
8. Operaciones.
9. Inmunizaciones

Etapas del examen físico:

1. Con el paciente sentado en la camilla. Se explora cabeza, incluyendo facies, conjuntivas oculares y cavidad oral. Cuello, pesquisando agrandamiento tiroideo u otras tumoraciones, así como ingurgitación yugular. Tórax y miembros superiores, con toma de la temperatura, la frecuencia respiratoria, el pulso radial y la tensión arterial.
2. Con el paciente en decúbito supino sobre la camilla. Se realiza auscultación del corazón. Se explora abdomen, incluyendo pesquisa de hernias y de agrandamiento hepatoesplénico u otras tumoraciones, y miembros inferiores que incluye palpación de pulsos pedios y pesquisa de deformidades de los pies. Exploración de mamas y sistema respiratorio. En los niños se examina el desarrollo psicomotor; en la mujer se debe realizar la exploración ginecológica siempre en presencia de una enfermera.
3. Destinada a pesar y tallar al paciente con miras a su evaluación pondoestatural (pesquisa de obesidad y de desnutrición). Preferentemente el peso debe expresarse en kilogramos y la talla en centímetros.

La historia clínica en la atención secundaria consta también de la anamnesis y el examen físico. En el interrogatorio se recogen los datos siguientes:

1. Identidad personal.
2. Motivo de ingreso o de consulta.
3. Historia de la enfermedad actual.

4. Antecedentes patológicos personales.
5. Antecedentes patológicos familiares.
6. Hábitos tóxicos, datos ambientales de interés y otros.
7. Historia psicosocial.
8. Interrogatorios por sistemas y síntomas generales.

Examen físico:

1. Examen físico general.
2. Examen físico regional.
3. Examen físico por sistemas:
 - a) Sistema osteomioarticular.
 - b) Sistema respiratorio.
 - c) Sistema circulatorio.
 - d) Sistema digestivo.
 - e) Sistema genitourinario.
 - f) Sistema hemolinfopoyético.
 - g) Sistema endocrino.
 - h) Sistema nervioso:
 - i) Examen neurológico.
 - j) Examen psíquico.